

## 09 - Module III

Dans cette partie, on va s'intéresser aux trois principaux courants de la sociologie de la santé. Il y en a d'autres, mais en l'occurrence les trois, ces trois, que sont le courant de structure fonctionnaliste, le courant de la théorie du conflit et puis après, finalement, l'intégralité symbolique, ont été les courants les plus fructueux, ceux qui ont été les plus générateurs d'idées, générateurs d'approches et qui ont été les plus suivis et qui ont constitué des courants de pensée, qui ont produit des informations, des recherches dans le domaine de la sociologie de la santé. Alors, chaque courant se caractérise, bien entendu, par ses concepts, par ses paradigmes qu'on va repasser au revu, aussi par son approche, c'est-à-dire sa façon d'appréhender l'angle sous lequel il va traiter la question de la santé et de la maladie, mais à chaque fois, nous allons signaler les limites de chaque approche, c'est-à-dire jusqu'où ce courant apporte des informations qui sont importantes et qui répondent à un certain nombre d'hypothèses, mais aussi jusqu'où ce courant-là n'apporte pas des informations supplémentaires, une compréhension supplémentaire des phénomènes qui sont étudiés.

En quel cas, les autres courants peuvent être considérés dans un premier abord comme étant des approches complémentaires ou alors comme des approches qui soulèvent d'autres questions sous d'autres angles. Donc, il est intéressant justement de traiter les différents courants pour voir un petit peu leur richesse, leur rapport, et puis qu'ils peuvent être mobilisés à différents niveaux pour différentes thématiques selon le contexte, selon la problématique. Dans cette partie, nous allons passer en revue les trois courants de la sociologie en vigueur dans le domaine de la santé.

Le premier est le courant de fonctionnalisme qui postule que les institutions sociales qui constituent la société, on peut prendre l'exemple de la famille qui joue un rôle important dans la socialisation de l'enfant dès son jeune âge, l'institution scolaire qui permet aussi de transmettre des savoirs, de donner une place future dans l'individu dans la société, et le système de santé qui, lui, aide à garder les gens en bonne santé. Alors, ces fonctions qui sont reconnues à chaque système constituent la spécificité de chaque système. Ce sont des fonctions qui, lui, sont reconnues, mais ce sont des fonctions qui, si elles sont dérégulées, posent justement un problème d'équilibre et rapidement le système essaie de corriger ce dysfonctionnement par un retour à l'équilibre ou par l'invention de solutions pour atteindre cet équilibre.

Donc, les mots-clés qu'on peut retenir en plusieurs, c'est d'abord la notion de fonction, les fonctions claires, les fonctions qu'on voit, mais aussi des fonctions latentes, des fonctions qu'on doit repérer, que le système peut jouer, mais qu'on ne voit pas. La notion de l'équilibre, la notion aussi de la mimie, c'est-à-dire l'absence ou dérèglement des normes ou des valeurs qui font que les dérèglements résultent justement de ce dysfonctionnement des valeurs, etc. Alors, en gros, la question que posent les fonctionnistes, vous avez au niveau de la colonne en face, c'est comment fonctionne un système de santé, quelles fonctions joue une institution hospitalière,

quelles régulations entre les différentes professions de santé, etc.

Donc, toutes les questions vont porter sur le système, sur son fonctionnement, sur les rôles joués par les différents acteurs qui composent le système, sur comment il y a un retour à l'équilibre quand il y a un dysfonctionnement, comment les différentes parties opèrent, comment elles font pour justement réguler cette situation et arriver à un stade d'équilibre. Alors, la deuxième théorie, ou le deuxième courant, c'est la théorie des conflits, et on verra l'utilisation aussi, les apports de cette théorie quand on va traiter des questions beaucoup plus spécifiques dans la suite de notre présentation. Alors, la théorie des conflits suppose que les individus et les groupes qui détiennent le pouvoir, s'approprient ce pouvoir au dépens d'autres qui n'en sont pas munis, qui en sont diminués en quelque sorte.

Donc, la théorie des conflits insiste, ou jette le regard sur cette question de conflit entre des structures puissantes et entre des groupes qui sont en bas de la hiérarchie. Les concepts qu'utilisent les théoriciens des conflits, bien entendu, ce sont des concepts qui entraînent en notion de la domination des uns par des autres, des inégalités, des notions d'aliénation, d'exclusion, de conflits, etc. Donc ça, c'est une autre approche qui ne postule pas, comme le fonctionnalisme ne postule pas l'équilibre, mais nous dit que la situation des conflits, c'est une situation normale et il nous importe de poser des questions par rapport à ces situations de conflits.

Alors donc, comme on l'a fait pour le fonctionnalisme, regardons un petit peu la colonne en face pour nous arrêter sur les questions que ça pose. Parmi les questions que traitent les théoriciens du conflit, la question des inégalités dans la société dont nous sommes ensemble, mais plus particulièrement dans le domaine de l'accès aux soins. Donc les chercheurs qui travaillent, qui utilisent cette théorie, vont traiter, par exemple, les conflits entre les compagnies d'assurance, entre les autres professions, vont traiter de la notion de l'exclusion de l'accès aux soins, de l'impact de la pauvreté, de la précarité, qui fait que malgré le discours de l'égalité, en réalité il y a une exclusion de fait, par rapport à un certain nombre de soins, etc., et donc, alors cette inégalité peut concerner des institutions, peut concerner des états, peut concerner le monde entier, peut concerner les pays du nord par rapport aux pays du sud, etc.

Donc ça c'est très important, cette approche-là, et donc on trouve pratiquement dans beaucoup de cas et de maladies une approche, ou des recherches qui ont utilisé cette approche-là, cette approche de l'inégalité sociale, et ça on y reviendra par la suite. Et puis le dernier courant, c'est celui de l'interactionnisme symbolique, c'est un courant qui souligne la façon dont les individus agissent avec les autres, c'est-à-dire comment ils rentrent en relation avec les individus, et aussi comment ils interprètent leur interaction. C'est un élément très important, parce que l'interaction, on peut prendre l'exemple, l'interaction entre les médecins et les patients, c'est une interaction assez spécifique et qui a fait couler beaucoup d'encre, ou qui a été l'objet de beaucoup de recherches.

L'interaction aussi entre les patients dans un hôpital, ou entre les patients et le personnel de

soins, l'interaction aussi entre les familles et les malades, donc voilà, cette approche-là focalise ces questions-là sur ces interactions, comment elles naissent, comment on les interprète, quel rôle elles jouent dans l'élaboration du sens donné à ces relations entre ces différentes personnes, entre ces différents groupes. Donc c'est une approche assez particulière et qui diffère de l'approche fonctionnaliste ou de l'approche basée sur la théorie des conflits. Alors le tableau suivant essaie de mettre en parallèle les trois courants qu'on vient de citer et bien sûr la façon dont ce courant traite les questions liées à la santé et aussi le niveau, le niveau à partir duquel chaque courant va analyser un aspect particulier.

Donc un des aspects sur lesquels la sociologie justement a beaucoup produit et a beaucoup inventé des concepts, des méthodes, mais aussi des approches très spécifiques et la question de l'échelle, l'échelle qu'on observe. Donc le niveau macro, c'est le niveau qui permet d'avoir une vue d'ensemble et qui implique l'utilisation d'une combinaison de plusieurs méthodes pour un peu voir de façon globale la société. Alors le niveau macro se concentre sur les grands aspects de façon globale.

Ça on va le retrouver dans le structureux fonctionnalisme mais aussi dans le conflit social et on va expliquer en quoi ça consiste. Un premier domaine des recherches au niveau macro donc vont s'intéresser aux structures, au domaine de la santé et donc les recherches impliquent d'analyser les comportements sociaux humains et aussi l'organisation sociale du monde, du monde humain de façon générale. Qu'est-ce qui est dans l'organisation dans notre société, dans son ensemble, explique par exemple l'existence de la maladie.

Qu'est-ce qui fait par exemple que des composantes du système de façon générale font que l'on fasse un choix plutôt qu'un autre. Donc on est à un niveau macro et dans un sens ces approches là permettent justement de comprendre de façon globale les structures dans lesquelles nous vivons. Elles permettent aussi de donner un autre regard assez global mais aussi qui permet de jeter la lumière sur les grands aspects.

Contrairement au niveau macro ou à ce qu'on appelle la macro sociologie, la micro sociologie, elle qu'on retrouve surtout au niveau du courant symbolique, va se concentrer sur les détails de la vie sociale. C'est une forme de sociologie dans laquelle les rôles sociaux, les interactions et bien sûr les systèmes de croyances sont considérés comme des caractéristiques clés des processus sociaux, une base pour les relations sociales et qui font l'objet d'investigations au niveau de l'action sociale, c'est-à-dire comment les individus agissent. Donc on essaie de comprendre l'expérience des individus, on essaie de comprendre le comportement social et la vie quotidienne des individus et des groupes dans la société plutôt que la façon dont les systèmes sociaux, les structures sociales globales, que ce soit la société, les états ou les grands systèmes comme c'est le cas pour les deux premiers courants que sont la structure au fonctionnalisme et le conflit social.

Dans ce cas-là, l'approche de l'action sociale part de l'individu pour comprendre comment lui

construit ses relations, comment il donne du sens à ce qu'il fait et en gros on part de l'individu pour comprendre la société, pour faire rapide alors que les deux autres courants qui s'inspirent de la macro-sociologie font la démarche inverse. On comprend d'abord les grands systèmes, on comprend la société pour après essayer de comprendre un petit peu les interactions des individus et le comportement des individus. Donc on est dans ce niveau-là, c'est un niveau qui focalise son regard sur l'individu.

Alors si on regarde de près pour voir un petit peu et pour justement donner des exemples pour ce qu'on vient de dire, alors si on prend le structure fonctionnalisme, on vient de le voir, l'image de la société qu'il donne ou qu'il adopte, c'est une image de système de parties indépendantes, c'est comme un système où les parties sont indépendantes, c'est un peu aussi parfois l'image d'un corps, l'image d'un corps composé de plusieurs organes et chaque organe a une fonction et cette approche organiciste qui considère la société comme un corps, suppose que dès qu'il y a une fonction qui tombe en panne, toutes les autres fonctions vont en souffrir. Donc c'est une complémentarité entre les différentes fonctions et qui fait que les choses marchent. Donc ça c'est une vision de la société qui s'inspire de l'approche du système ou de l'approche parfois organiciste qui regarde la société comme un tout et en équilibre.

Donc c'est un regard qui a produit beaucoup de recherches et qui a essayé de développer des questions très spécifiques, celles qu'on retrouve au niveau de la quatrième colonne à droite. Quels sont les composants du système ? Donc ça c'est la première question que l'on peut se poser. Quels sont les parties de ce système ? Quelle est la fonction des soins de santé au sein du système et comment elle est liée aux autres institutions par exemple ? Donc ça c'est une question qu'on peut se poser.

Quelle est la fonction du soin par exemple au sein de l'hôpital ? Mais cette fonction de soin, est-ce qu'elle n'est pas liée à d'autres fonctions au sein de l'hôpital qui ne sont pas uniquement des fonctions de soins, il y a d'autres fonctions. Et aussi on peut considérer que l'hôpital lui-même ou l'institution hospitalière, elle fait partie aussi d'un système beaucoup plus global et comme on l'avait dit tout à l'heure, quelle est la relation entre l'hôpital et les autres institutions. Voilà, l'approche fonctionnaliste en fait, elle cherche à comprendre en fait de façon globale un petit peu les systèmes, leurs relations, les fonctions, comment ces fonctions sont nées, comment elles sont maintenues et comment font ces structures pour gérer justement la durabilité en fait de ces fonctions et quand il y a un dysfonctionnement, comment on arrive à réparer en fait ce dysfonctionnement.

Donc rappelez vous que cette vision du système comme un corps aussi nous conduit à penser que dès qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un système donné, tout le reste va avoir des déficits, va avoir des problèmes, va connaître comme un corps, dès qu'il y a une partie qui tombe malade, les autres parties aussi. Donc il y a une tendance à ce que tout le système se met en marche pour régler ce problème, ce dysfonctionnement. Et donc il y a une collaboration entre les différents systèmes en quelque sorte, il y a une mise en commun si vous voulez des problèmes

connus par une partie du système qui font qu'on essaye de revenir à une situation d'équilibre, à une situation qui permet un retour au bon fonctionnement.

Le deuxième courant qui focalise sur le conflit social, contrairement comme on l'a dit, lui regarde la société comme étant toujours en conflit, que le conflit c'est quelque chose qui n'est pas exceptionnel mais qu'il est au coeur du développement de la société, que le conflit est le moteur du changement de la société. Et observer un conflit, justement jeter la lumière sur un conflit permet de comprendre quelque chose de tout à fait normal de l'évolution des sociétés, l'évolution des différents systèmes. Alors par exemple le conflit entre les syndicats, entre le patronat, entre les professionnels et les politiques, entre les associations de malades et entre l'état, pour cette approche là ce sont des choses tout à fait normales.

Et c'est grâce à ces conflits que les choses peuvent changer, parce qu'il y a toujours cette tendance à ce que les acteurs entreront en conflit, chacun défend son point de vue et que ceux qui gagnent la partie c'est eux qui imposent leur vision en quelque sorte. Jusqu'à ce qu'une autre catégorie émerge ou jusqu'à ce que les éléments du contexte changent et puis voilà de nouveau en fait le conflit permet, un nouveau conflit qui se déclenche et ça permet d'évoluer par rapport à cette situation. Donc pour les tenants de ce courant, le conflit n'est pas du tout quelque chose tout simplement comme on dit à résoudre ou à écarter, mais le conflit c'est quelque chose à observer, à accompagner parce que c'est quelque chose de bénéfique.

Donc ça c'est une vision assez particulière et qu'il faut en tenir compte, surtout dans les questions qu'elle pose. Alors parmi les questions c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est comment l'inégalité sociale contribue-t-elle aux disparités de l'état de santé entre les différents groupes. Et ça on va le voir parce que quand on va discuter du droit à la santé, qu'on va discuter de tous les programmes de promotion de la santé actuelle par l'organisation mondiale de la santé, mais aussi par les états, par justement ce souci de faire de la santé un bien auquel tout le monde a droit, on va être confronté à ce genre de questions.

Est-ce que justement la réalité est telle qu'il y a des inégalités, que ce soit des inégalités liées à l'âge, au sexe, à l'origine ethnique, à l'origine géographique, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination par les prix, les prix sont tellement chers que de ce fait là, le marché fait que des soins fait qu'un certain nombre de catégories ne peuvent pas y accéder. Alors on peut poser aussi la question, que peut faire l'état, que peut faire les décideurs politiques, vous jouez un rôle tampon si vous voulez, un rôle justement de régulation de ces discriminations.

Donc voilà un petit peu, ce sont des questions qu'on va retrouver et justement qui ont été soulevées par les gens qui travaillent, par les chercheurs qui travaillent sur ces questions là. Et puis le dernier niveau, comme on l'a vu, qui est aussi, qui a son importance, et là on a parlé justement dans le tableau précédent des différentes questions, on va en citer quelques unes nouvelles. Le courant d'interactionnisme dit interactionnisme symbolique, qui lui se situe au niveau de l'individu, de l'interaction de l'individu avec d'autres individus.

Comme on l'a dit, entre le malade et le médecin, entre les médecins, entre les malades d'un autre côté, entre les malades et leur famille, entre les familles etc. Donc les interactions sont nombreuses. Et ce courant là nous dit que la réalité de la société se construit à travers ces interactions.

Donc le plus important c'est d'aller observer ces interactions, comment elles naissent, qu'est-ce qu'elles ont comme sens, qu'elles reflètent comme sens. Donc il n'y a pas quelque chose d'a priori etc. C'est la liberté des gens, c'est aussi la façon dont les gens produisent et donnent du sens à leurs relations avec les autres, qu'il faut essayer de comprendre.

Par exemple, comment les symboles, les uniformes qui sont portés par différents professionnels de la santé agissent ou influencent la perception qu'à le malade, c'est un symbole, qu'à le malade des pouvoirs d'un médecin ou de l'infirmier. Parmi les symboles, parmi les questions que l'on se pose, c'est aussi le type de communication, est-ce que la communication est descendante, c'est-à-dire dans un sens unique, dans quelle mesure l'interaction entre le médecin qui lui utilise un langage très savant face à un patient qui lui va utiliser plutôt un langage plus usité, qui relève plutôt du savoir profane et pas du tout du savoir scientifique, comment ils peuvent tous les deux dans cette interaction produire du sens, donner du sens. Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre le savoir du médecin et le savoir du patient.

Quelle interaction entre le médecin dans la prise de décision sur les maladies, au niveau de la gestion d'un certain nombre de cas très urgents, et aussi la place des infirmiers. Donc vous n'êtes pas sans savoir que ça c'est une question qui a fait l'objet de beaucoup de débats, surtout lors de la crise de Covid-19, avec justement tout le rôle joué par des infirmiers, des infirmiers qui étaient dans les premières lignes, qui étaient eux-mêmes qui étaient justement en prise avec la maladie, et si bien qu'il fallait s'occuper du malade, de bouton, de son alimentation, son hygiène, au moment où il était en prise directe avec la maladie, et qui ont demandé à ce qu'il y ait plus de reconnaissance. Pour ceux et celles qui ont suivi le débat, il y a une demande de reconnaissance de ce sacrifice des infirmiers, au moment où les médecins étaient sur d'autres fronts.

Donc ça pose ces questions d'interaction entre celui qui détient le pouvoir, celui qui est imposé un avis, une opinion, etc. dans le domaine hospitalier, ça fait l'objet aussi de beaucoup de recherches dans le cadre de l'interactionnisme social. Donc ça c'est parmi les premières questions, c'est un avant-goût de ce qu'on va voir de façon très précise par rapport à chaque courant.

Alors commençons par le structuralisme fonctionnalisme. Parfois on utilise le fonctionnalisme tout court, mais en général parfois on utilise le structuralisme fonctionnalisme pour justement parler de ce courant. Alors la spécificité de ce courant, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, la société est considérée comme un système complexe, et puis qui tend vers la stabilité, vers l'équilibre.

Cette notion de système, on la trouve aussi dans d'autres domaines, par exemple quand on parle

d'écosystème ou des systèmes écologiques, quand on parle de système de soins, quand on parle de système économique, de système politique, etc. Donc la notion du système c'est quelque chose qu'on voit dans différents domaines, mais globalement elle est basée sur les mêmes éléments, c'est-à-dire que tout le système est constitué de parties qui fonctionnent ensemble et qui ont tendance à promouvoir la stabilité, l'équilibre s'il vous plaît. Donc dans le domaine qui nous intéresse, le vécu, les comportements sociaux au niveau de la société pour ce courant sont guidés par des structures sociales.

Et donc ce sont des rôles et des fonctions qui sont dictés, qui sont là. En l'occurrence, dans le domaine de la santé, on le verra que ce courant fonctionnaliste nous dit ce qu'est la fonction du médecin, ce qu'est la fonction de l'hôpital, qu'est-ce que la fonction aussi du malade. Donc ce qui est au cœur de cette démarche c'est l'identification des différentes fonctions et de la complémentarité entre ces différentes fonctions qui est le garant de l'équilibre, de l'équilibre social de façon générale.

Alors les plus grands représentants de ce courant, donc on avait parlé au niveau de la première présentation de notre cours sur l'introduction à la sociologie d'Auguste Comte, on avait aussi parlé d'Emile Durkheim, mais Herbert Spencer et Talcott Parsons figurent comme une des figures principales de ce courant-là. Et on verra l'approche de Parsons dans le domaine de la sociologie de la santé. Donc l'approche fonctionnaliste, alors deux auteurs vont jouer un rôle extrêmement important dans cette approche fonctionnaliste dans le domaine de la santé.

Le premier c'est Robert Merton qui va lui présenter trois concepts liés à la fonction sociale, ce qu'il appelle lui les fonctions manifestes, c'est-à-dire les fonctions qui sont reconnues, qui sont visibles, mais aussi ce qu'on appelle les fonctions latentes, ce sont des fonctions qui sont méconnues ou involontaires et qui méritent qu'on jette la lumière dessus. Et puis finalement il a utilisé le concept de dysfonctionnement social, dysfonctionnement social de façon générale, et puis qui sont aussi des conséquences indésirables d'un modèle social du fonctionnement de la société. Donc en postulant qu'il y a des fonctions manifestes qui sont visibles, qu'on peut étudier, qu'on peut repérer, il y a des fonctions latentes qui ne sont pas visibles et qu'il convient justement de découvrir.

Et cette approche fonctionnaliste qui a été lancée et développée par Robert Merton va être adoptée par beaucoup d'auteurs qui vont partir à la recherche, à la compréhension des différentes fonctions au niveau du système de santé, celles qu'on voit mais aussi celles qui sont latentes, qu'on ne voit pas. Alors qu'on ne voit pas, ça peut être des fonctions aussi d'ordre social, qui ne sont pas clairement prescrites ou clairement inscrites dans le payé-charge, ou dans la lettre d'admission, mais il y a d'autres fonctions. Et puis la question du dysfonctionnement social a fait aussi l'objet d'études justement par les tenants de ce groupe.

Alors Talcott Parsons, c'est la figure, si vous voulez, du fonctionnalisme dans le domaine de la santé. Alors lui, il se base sur la notion du système social de façon générale, mais il a beaucoup

développé la notion du concept du rôle du malade. Alors le rôle du malade dans l'institution, que veut-il dire, que signifie-t-il, etc.

Et que du coup, lui, il installe le malade comme un élément du système, qui participe aussi justement à l'élaboration de la construction de la maladie, et à l'équilibre de ce système-là, en jouant un rôle très précis, en jouant une fonction assez précise. Et puis, un dernier élément dont on parle de Talcott Parsons, c'est celui de l'état de bonne santé, qui résulte justement d'un prérequis de fonctionnement correct pour l'individu comme pour la société. Alors l'individu malade, c'est un individu qui va accepter d'être malade, et que cette fonction, ce rôle d'être malade, c'est un rôle qui est considéré, on le verra, comme quelque chose d'assez particulier, et qui est au contraire aux règles normales.

Et que le rôle de la médecine, c'est le rôle justement du médecin, c'est de faire récupérer au malade son statut antérieur, ce qui lui permet de retourner à la société, d'être un élément positif dans le fonctionnement de la société. Donc ça, c'est l'approche de Talcott Parsons, qui va influencer pendant plusieurs décennies les recherches dans le domaine de la santé, et de la sociologie de la santé. Alors comme on vient de le voir, le rôle de malade selon la théorie fonctionnaliste de Talcott Parsons, il nous dit que ce rôle, il est défini par un certain nombre d'éléments, c'est que le malade se comporte d'une certaine manière, du moment quand il sait, il se sait malade.

Deuxième élément, la société applique des règles aux personnes malades, en reconnaissant que ces personnes malades peuvent être justement excusées, en quelque sorte, d'un certain nombre d'obligations. Et que le malade doit montrer justement qu'il a une volonté, il doit montrer sa volonté de chercher de l'aide médicale, pour justement récupérer son état antérieur et aller mieux. Et puis la société, justement pour excuser le malade des rôles qu'il jouait auparavant, va justement ne pas tenir le patient responsable de sa maladie.

Et ça, c'est un engagement c'est quelque chose que le malade doit lui-même accepter et que dans les règles de jeu, c'est ainsi qu'on va considérer la maladie. Alors ce qui est propre de la théorie fonctionnaliste, c'est que la société considère les individus comme ayant une fonction et donc s'ils ne remplissent pas cette fonction, ils vont porter atteinte au l'équilibre et au fonctionnement correct de la société. Et c'est dans ce cadre là qu'être malade, c'est une défaillance, ça permet de soustraire la personne à ses obligations.

Et dans ce cas, l'individu a l'intérêt et l'obligation d'aller mieux pour reprendre et contribuer au bon fonctionnement de la société. Alors en ce qui concerne l'étude de la santé et de la maladie, du point de vue de la perspective fonctionnaliste, on peut dire qu'elle est éclairée ou focalisée ou cristallisée autour du concept du rôle du malade. Alors le rôle du malade c'est un concept qui a été utilisé pour analyser la maladie comme un rôle social et pas seulement comme un état biologique ou une expérience physique.

Pour les fonctionnalistes, tant qu'autre personne va donner les caractéristiques de ce qu'est le rôle du malade, pour eux, toute société fonctionne correctement. Du coup, la maladie doit être gérée de telle sorte que la majorité des gens maintiennent leur rôle et leurs obligations normales. La maladie est considérée comme une rupture par rapport à la normalité, comme une déviance, donc ça c'est le mot clé, par rapport à une situation de fonctionnement normal.

Alors cette perspective fonctionnaliste est fondée sur l'hypothèse suivante, si trop de personnes se décrivent comme malades et ont besoin d'être dispensées de leur travail et de leurs obligations sociales, il sera difficile de maintenir le fonctionnement de la société et on risquera de voir une perturbation de la société dans son ensemble. Donc ça c'est l'hypothèse qui a été mise par Sants. Alors la conclusion c'est que, étant donné que la maladie signifie un choix de se retirer des obligations, des schémas normaux, comme disait Tarkov Parson, du comportement social, cela équivaut à décrire la maladie comme une déviance, c'est à dire une situation qui n'est pas normale, qui peut être momentanément anormale et qu'il faut dans l'approche fonctionnaliste essayer de traiter pour redresser la situation, pour revenir à un bon fonctionnement du système social.

Et de ce fait là, cette forme de déviance qu'est la maladie appelle un contrôle du système social et de tout ce qui est relève de la maladie, en lui donnant justement un certain nombre de critères, en lui reconnaissant un certain nombre de critères, en reconnaissant aussi les personnes qui se disent malades et puis en reconnaissant aussi le rôle du médecin qui va justement jouer un rôle pour réparer cette situation. Globalement le rôle de la médecine pour l'approche fonctionnaliste, et de réguler et donc de contrôler ceux qui sont malades ou qui ont décidé d'être malades, dont l'objectif de reprendre, de les aider, de les appuyer ou de les amener à reprendre les tâches et les responsabilités normales. Donc le rôle malade demande un engagement de la part de ceux qui ne se sentent pas bien et qui se disent malades, c'est un engagement de leur part pour revenir à la normalité le plus tôt possible.

Donc ça c'est la première chose qui est définie comme un élément de reconnaissance par le malade de cette nécessité de revenir à la situation normale. Alors un certain nombre de caractéristiques définissent le rôle du malade. D'abord les personnes malades vont être en quelque sorte exemptées des responsabilités sociales, normales, associées au travail et bien sûr à d'autres responsabilités familiales etc.

Donc ça c'est un premier élément. Donc cette exception, l'exemption des responsabilités fondamentales qui est justement une situation d'exception par rapport à une situation de normalité pendant la phase de la maladie. Le deuxième élément qui est extrêmement important pour les fonctionnalistes, c'est que les malades ne peuvent pas eux seuls guérir par une action de décision personnelle.

Donc ils ne peuvent pas s'améliorer et ils ont besoin d'une aide professionnelle. Donc ça c'est un élément clé qui va amener à une troisième hypothèse, celle qui dit que les malades sont obligés

de vouloir, sont contraints en quelque sorte, de vouloir aller mieux, de vouloir guérir, parce que la maladie n'est pas tolérée, parce qu'on souhaite d'être malade. Non, il faut qu'il y ait un souhait de guérir, c'est-à-dire de revenir à son rôle social et de vouloir aller chercher de l'aide.

Et bien sûr cela nous amène au quatrième point qui caractérise le rôle du malade et qui dit que le malade est censé chercher un traitement, mais un traitement professionnel. Il ne suffit pas que lui prenne un certain nombre de dispositions personnelles, d'expérimentations. Non, il faut qu'il aille voir quelqu'un qui est professionnel, qui est capable, parce que c'est son rôle de le ramener vers un état de santé, le ramener vers un état de santé normal et du coup le ramener au TLD à revenir à ses fonctions qu'il remplissait au sein de la société.

Donc cette approche-là du rôle du malade en jetant la lumière sur le rôle des autres éléments que sont la profession médicale et son rôle aussi dans la prise en charge et dans l'appui qu'elle peut donner justement au malade pour revenir à une situation normale. Donc pour les fonctionnalistes, comme on l'a vu, ils focalisent sur la notion de l'équilibre, la notion du retour à un état normal, un état de coopération, un état de collaboration, un état de bon fonctionnement. Et c'est en cela qu'ils se sont distingués par ces approches qui ont jeté la lumière sur tous ces aspects de complémentarité des rôles des uns et des autres dans les institutions hospitalières, entre les institutions hospitalières et d'autres institutions, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient privées, qu'elles relèvent de la société civile comme les associations.

Donc l'approche de l'analyse des rôles et du bon fonctionnement a été étendue à d'autres composantes qui ont trait à la santé. On arrive aux critiques et aux limites de l'approche fonctionnaliste qui peuvent être résumées en 4 points. Le premier, c'est que dans la réalité, il est très difficile parfois de trouver toujours des situations simples, des situations où des fonctions sont claires, celles des médecins, celles des malades, celles de la société, des infirmiers, etc.

Mais qu'on est dans des situations complexes, où les fonctions dépendent aussi des contextes, de l'équilibre, de là où on se situe, etc. Donc il n'y a pas une règle générale qui peut s'appliquer à toutes les situations. Également, les relations entre les malades et la société ne se résument pas à ces questions de relation entre une personne qui sort du système, au moins qui est excusée à un moment donné, le temps qu'elle recouvre sa santé.

Donc c'est une espèce d'entrée et de sortie. En général, la relation est beaucoup plus complexe que cela. Et ce n'est pas une question uniquement de geler les activités et d'excuser le malade pendant un moment donné, le temps qu'il recouvre sa santé.

Il y a d'autres relations beaucoup plus spécifiques. Si on prend le cas des maladies chroniques, le malade ne dispose pas de soins immédiatement pour retourner à la société. Mais dans le cas de la maladie chronique, souvent le malade doit vivre avec la maladie, ce qu'on ne verra pas la suite dans le cadre de l'expérience de la maladie.

On n'est plus dans le cadre de retour à une situation d'équilibre, mais à une nouvelle négociation

avec une nouvelle situation. La maladie chronique pose de nouvelles questions et de nouvelles situations auxquelles l'approche fonctionnaliste ne donne pas des réponses. La deuxième critique ou reproche à la théorie fonctionnaliste, c'est qu'ont été souvent omis d'autres facteurs qui jouent dans la question de la santé, dans la question de la relation des malades avec la société ou des malades avec les médecins, etc.

Ce sont toutes les questions liées à la représentation de la maladie. Quelqu'un qui se dit malade, il part d'un certain nombre de représentations qui ne sont pas forcément celles qu'il partage avec d'autres personnes. Le comportement, c'est-à-dire la décision de franchir le pas d'aller voir le médecin, dépend aussi d'autres facteurs, qui sont des facteurs culturels, qui dépendent aussi du niveau d'instruction, du capital social, de la classe, etc.

On est devant des situations qui peuvent être beaucoup plus complètes que ce que nous laisse croire l'approche fonctionnaliste. La relation entre le médecin et le malade n'est pas uniquement une relation instrumentale, c'est un malade qui assume son rôle de malade, qui va justement prendre la décision d'aller se faire soigner et de déléguer cette responsabilité au médecin, qui lui a pour rôle de ramener le malade à un état de guérison et à un état normal. Au contraire, il y a une complexité de relation qui peut être modulable dans la durée et qui peut être négociée, qui peut changer selon le comportement du malade, selon l'évolution de la maladie, selon les étapes qu'il faut franchir.

Ce n'est pas une relation instrumentale, mais c'est une relation à inventer, ça dépend de chaque contexte, ça dépend du malade, ça dépend de la relation qu'il a tissée avec le médecin. Et finalement, la maladie selon l'approche fonctionnaliste est une déviance, et considérée comme déviance, ce n'est pas toujours le cas, parce que dans beaucoup de cultures ou de milieux, la maladie n'est pas considérée comme une déviance, tel que nous le décrit la théorie fonctionnaliste. Le marxisme comme théorie, comme approche fournit un aperçu de la structure de la société basé sur les idées suivantes.

D'abord, la structure économique de la société détermine les relations de cette société. Deuxième idée, la répartition de la propriété des moyens de production donne naissance à des schémas de relations de classe, qui de façon cruciale dans toutes les sociétés de classe se caractérisent inéluctablement par des inégalités de pouvoir. Troisième idée, c'est que la société étant divisée entre ceux qui possèdent en privé les moyens, c'est une minorité, et ceux qui dépendent de la vente de leurs forces de travail, des salariés, des ouvriers, pour gagner leur vie, et que constitue la majorité.

Quatrième idée, c'est que la relation entre ces deux classes, en l'occurrence la bourgeoisie et le prolétariat, est une relation inégale, c'est une relation d'exploitation, même si c'est une relation oppressive, en profit de ceux qui détiennent les moyens. Cinquième idée, on peut dire que la théorie marxiste s'intéresse aussi à la manière dont la structure économique qui domine dans la société va déterminer l'inégalité du pouvoir, et va ainsi façonner les relations qui vont déterminer

les autres institutions sociales. L'explication marxiste, dans le domaine de la santé, va porter sur la cause de la mauvaise santé, et les relations entre l'état et la profession médicale.

Basé sur la compréhension de la nature de ces relations, entre la santé et la maladie, et entre la façon dont la société organise le système de santé. Donc comment va s'exprimer en fait cette approche ? En mettant l'accent principal sur la manière dont la définition et le traitement de la santé et de la maladie sont influencés par la nature de l'activité économique dans une société capitaliste. La médecine sera donc une institution sociale majeure, mais elle est façonnée par des intérêts d'une minorité détenant le capital ou les capitalistes.

Donc les travaux qui ont porté sur ces aspects là ont été développés par de nombreux sociologues qui ont essayé d'analyser les politiques de santé. Pour certains auteurs, on peut citer un auteur qui est connu de ce courant, Navarro, qui nous dit qu'il y a quatre caractéristiques qui définissent la société, plutôt la santé et la médecine, dans une société capitaliste. D'abord il pointe l'invasion de la médecine par le capital.

La médecine selon lui aussi a changé d'un métier individuel, d'une profession individuelle, pour être une compétence gérée en médecine d'entreprise. Pour cet auteur et pour beaucoup d'auteurs qui s'inscrivent dans l'approche marxiste, la médecine est devenue de plus en plus aussi spécialisée et hiérarchique. Ce qui fait qu'on dispose de plus en plus de main d'oeuvre salariée, comme c'est le cas de tous les employés dans l'industrie.

On peut citer aussi les employés de toute l'industrie pharmaceutique et des secteurs qui sont industriels, qui sont connexes. Pour ces auteurs, les médecins sont devenus parfois prolétarisés, c'est-à-dire que leur statut professionnel a été progressivement compromis par la prise en charge par une autre catégorie, en l'occurrence le personnel administratif ou aussi la direction de la prestation des soins de santé. Parfois des actionnaires, parfois des gens qui sont extérieurs au domaine de la santé.

Alors ces quatre processus pour ces auteurs signifient aussi que le médicament va devenir un produit commercial, un produit à acheter et à vendre, comme tout autre produit. Et du coup il va devenir de plus en plus rentable pour les intérêts capitalistes dominants. Et il va faire l'objet de débats quant à son prix, quant à sa rentabilité, entre le secteur financier qui est devenu un acteur fort dans le domaine de la santé, des bailleurs, des banques, des financiers, etc.

qui injectent des fonds dans ce domaine, mais aussi tout le secteur des assurances privées qui aussi gagne dans ce secteur, ils se sont imposés aussi comme un acteur important. Et puis l'ensemble de tous les autres acteurs qui s'impliquent ou qui ont développé des compétences ou qui se sont positionnés, notamment dans tout ce qui est vente de médicaments et vente d'instruments divers médicaux. Ainsi que tous les appareillages, etc.

Donc pour ces auteurs et ces chercheurs qui ont travaillé sur ces aspects là, en utilisant des

enquêtes, des observations de terrain, et puis des entretiens avec plusieurs institutions hospitalières, avec plusieurs responsables d'entreprise, avec les ouvriers, avec les médecins, les ouvriers en l'occurrence des industries pharmaceutiques. Conclu que le pouvoir de diriger et d'exploiter le système médical globalement a été confisqué par de grandes entreprises maintenant qui jouent en quelque sorte un rôle monopolistique. C'est à dire qu'ils détiennent seul le monopole sur le secteur et imposent de ce fait là leur point de vue et défendent leurs intérêts.

Alors ce processus là, comme l'observent ces auteurs et ces chercheurs sociologues, pour eux c'est un processus qu'on observe aussi dans d'autres secteurs. Ou le capital, dès qu'il intervient et s'impose, il domine rapidement, soit directement via le secteur privé qui prend d'assaut les institutions hospitalières, le secteur pharmaceutique, la production des appareils, des outils, des médicaments, etc. Mais aussi indirectement via l'état.

Donc on verra que ces auteurs n'excluent pas les systèmes ou même en l'absence de monopole du secteur. Comme c'est le cas de la Grande-Bretagne, où il existe un système national de soins de santé. Alors même dans ce cas là, les auteurs disent que cela ne signifie pas que la médecine est libre de toute influence capitaliste.

Puisque l'état a tissé des relations extrêmement complexes avec le milieu, ce qu'ils appellent eux, le milieu industriel, le milieu médical. Ce qui implique aussi des relations extrêmement étroites avec des influences entre les grandes entreprises et les agences de l'état. Et donc ces grandes entreprises influencent les décisions de l'état, influencent les choix.

Et donc pour ces auteurs, même dans un système où le système commun anglosaxon reste géré par l'état, mais en fait il est indirectement manipulé par ces groupes pharmaceutiques, par ces grandes entreprises. Alors comment cela se manifeste dans ce genre de situation, où l'état continue à acheter des médicaments et des équipements auprès de ces grandes entreprises, en subventionnant parfois aussi leurs recherches par le biais de laboratoires universitaires. Mais aussi en entretenant toute l'infrastructure hospitalière.

Pour les auteurs de ce courant de la théorie des conflits, ils affirment également que les problèmes de santé aussi sont étroitement liés à des environnements de travail. Que connaissent aussi bien les médecins, que les personnels soignants, que les ouvriers de façon générale dans tout le secteur qui est lié de près ou de loin à la santé. Et qui sont des environnements de travail très stressants, voire nuisibles pour leur santé.

Et donc là on a vu émerger un certain nombre d'analyses récemment qui versent un petit peu dans ce courant. Récemment par rapport à l'application et par rapport à la fatigue voire le burn-out des médecins et du personnel de santé de façon générale. Dans la gestion de la pandémie et du fait que de tout le sacrifice, de tout le travail, à l'heure contrepartie il n'y a pas eu une reconnaissance réelle de l'état.

Enfin jusque là. Donc il y a eu un appel justement à reconnaître un petit peu tous les efforts,

surtout que les médecins et le personnel de soins a été dans les premières lignes face à la maladie. Et tous les pays déplorent même le décès d'un certain nombre de personnes qui se sont adonnées à ce travail.

De façon altruiste et qui ne calculaient ni leurs heures ni leurs implications pour contrer la propagation de l'épidémie. Ces auteurs pointent du doigt aussi le fait que l'alliance et donc la proximité entre les classes dirigeantes et la profession médicale parfois engendre des conditions d'inégalité. Car globalement ils ont observé que les classes dirigeantes exigent un type de soins, un type de santé particulier, exigent un traitement particulier.

Et donc tirent un petit peu la santé vers une forme de santé qu'ils imposent. Donc au delà de tous ces aspects, la théorie du conflit va mettre le doigt aussi sur les inégalités de façon générale, aussi du côté des malades quant à leur pouvoir d'accéder aux soins de santé. Donc ça c'est en analysant par exemple des inégalités qui peuvent être des inégalités spatiales entre les zones rurales, les zones urbaines, les zones périurbaines.

Parfois dans les pays, par exemple en Amérique Latine, les inégalités entre les zones, ce qu'on appelle les favelas par exemple au Brésil, qui sont des quartiers de bidonvilles, ou en Afrique dans certaines capitales africaines qui ont connu une explosion démographique et qui ont fait qu'au sein de la ville il y a des inégalités énormes avec le développement de poches de pauvreté qui sont très très difficiles à résorber. Les inégalités peuvent être aussi basées sur le revenu, sur la capacité de payer le service de santé, et donc ça on le trouve dans un certain nombre de pays, même parmi les pays les plus développés, parfois dans les pays comme les Etats-Unis où le service est payant et parfois n'est pas pris en charge rarement par l'Etat, donc ça a créé des inégalités de fait. Entre les inégalités, comme on l'avait dit à un moment donné, peuvent surgir aussi par rapport à des critères qui sont liés aussi à l'origine.

C'est le cas par exemple entre les immigrés et les nationaux dans les pays d'accueil comme c'est le cas en Europe avec tout le différentiel qui peut exister entre le pouvoir d'achat et donc la capacité d'accès au service de santé entre les immigrés et les nationaux eux-mêmes avec tout ce que cela signifie comme discrimination par rapport à l'information, par rapport à la prise en charge, par rapport au ciblage des soins, par rapport au suivi, à l'accompagnement de ces personnes, etc. Donc tous ces aspects-là ont fait l'objet depuis pratiquement maintenant, depuis les années 70 du XXe siècle avec l'arrivée des grandes vagues de migrations. Donc d'aucuns ont parlé de la détresse, d'autres ont parlé de l'effet stressant que vivent les immigrés dans les pays d'accueil parce qu'ils n'ont pas accès à un certain nombre de services.

Donc toutes ces études qui sont développées dans le cadre de l'approche MAXIS continuent à être développées en regardant toujours, en focalisant sur cet aspect de conflit, d'inégalité, d'exclusion, parfois de distension, parfois de confrontation. Alors comme on l'a vu pour la théorie fonctionnaliste, l'approche par la théorie du conflit connaît aussi des limites. D'abord la société est vue comme une arène de combat, c'est-à-dire de confrontation entre les différents acteurs.

La plupart des sociologues qui ont privilégié le paradigme du conflit essaient de comprendre la société mais aussi d'intervenir dessus. Donc l'objectif n'est pas uniquement de comprendre mais aussi d'avoir une prise, de pouvoir donner des directives, de donner des orientations pour que ce soit une sociologie de l'intervention sociale pour changer, pour modifier cet état des lieux. Et donc ça c'est un aspect qui a été très visible, très prégnant dans l'étonnement de cette théorie et qui fait dire à certains auteurs et à certains critiques que ce parti pris peut amener à une prise de position qui peut être subjective, qui peut être liée aux convictions du sociologue, ces convictions qui peuvent être méditantes, qui peuvent être bien sûr critiques mais qui n'est plus du domaine pur de l'observation objective.

Donc ça c'est une première critique. La deuxième critique c'est que les analystes dans le cadre de la théorie du conflit ont tendance à ignorer l'unité sociale basée sur l'interdépendance. En forçant le trait du conflit, en forçant le trait des inégalités, en forçant le trait de la confrontation entre des classes, entre des intérêts divergents, ils omettent en quelque sorte la capacité de tous ces acteurs de tisser des alliances, de s'entendre, de négocier et de tendre vers des solutions beaucoup plus consensuelles.

Ils ont donc cet aspect de consensus qui est souvent en quelque sorte passé sous silence par ces auteurs qui, en voulant jeter uniquement la lumière sur l'aspect conflit, ils exagèrent en quelque sorte cet état-là et ne mettent pas en valeur les autres processus de négociation, les autres processus où il y a parfois un va-et-vient, parfois ça prend beaucoup de temps mais ça ne s'exprime pas forcément en confrontation directe. Ce sont des articulations, ce sont des intérêts parfois mutuels et finalement les acteurs arrivent, tant bien que mal, à des solutions qui répondent à leurs intérêts collectifs et mutuels et aux intérêts de chacun. Donc comme on l'a dit, cette théorie du conflit est engagée politiquement et de ce fait là, elle ne peut pas prétendre, comme le disent ces critiques, à l'objectivité scientifique.

Parce que c'est une position qui porte en projet politique de changer la société, de modifier les rapports de force et donc de ce fait là, elle est plus dans l'action, elle est plus dans un projet de changer ses rapports sociaux plutôt que de les comprendre de façon tout à fait objective, sans s'y mêler. Alors quatrième limite que les critiques de cette théorie ont émis, c'est que cette théorie est souvent basée sur de grandes structures, notamment la notion de classe, de groupe d'intérêt. Les bourgeois, les prolétaires, etc.

ont tendance à sous-estimer la capacité de l'individu de prendre des décisions, de faire des choix et que même les individus qui appartiennent à des classes dites pauvres peuvent émerger, peuvent s'imposer, peuvent justement, par le biais de l'ascension sociale ou de la mobilité sociale, peuvent aussi se positionner du côté de ceux qui détiennent le pouvoir. Donc ça c'est quelque chose qui a été en quelque sorte minimisé ou nourri par les analystes de la théorie du conflit qui ne reconnaissent pas à l'individu une capacité de changer de statut et de pouvoir aussi peser de son poids, de développer des stratégies aussi pour changer le rapport de force entre

ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent. Le troisième courant qui a joué un rôle extrêmement important à côté de l'analyse fonctionnaliste ou de la perspective fonctionnaliste et de la perspective basée sur la théorie du conflit est le courant de l'interactionnisme symbolique.

C'est un courant qui s'est distingué d'abord par la perspective qu'il va choisir en partant cette fois-ci des individus ou de petits groupes et non pas des grandes structures pour comprendre le monde social comme ça a été le cas pour le courant fonctionnaliste et le courant marxiste. Non, les tenants du courant de l'interactionnisme symbolique sont convaincus qu'en partant des individus, en observant les interactions individuelles, on peut comprendre le sens que les individus donnent à leurs gestes, à leurs comportements, à leurs attitudes. On peut comprendre justement ces interactions en les observant, en allant regarder de près comment au sein par exemple de petits groupes, des individus peuvent discuter et comment ils font évoluer au sein de petits groupes leur avis les uns et les autres et comment ils interagissent par rapport à des questions liées à la maladie, à la protection sociale.

Et donc cet aspect là on le retrouve aussi dans la vie quotidienne, dans la famille, on le retrouve dans l'hôpital, soit dans des petits groupes professionnels, des personnels soignants, soit entre les personnels soignants et les malades, soit entre les malades, etc. Donc ces interactions diverses ne préjugent pas de la force d'un groupe comme ça a été le cas pour les deux autres courants qu'on a vu auparavant. Non, elles étudient ces interactions qui permettent aux individus, que ce soit les patients, beaucoup de travaux ont porté sur comment les patients se représentent la maladie, comment ils construisent leur avis, à partir de quel capital et de connaissances ils vont piocher des informations pour se faire une idée sur leur situation.

Mais ces recherches ont porté aussi sur l'interaction entre le patient et le médecin, ou entre le médecin et les infirmiers. Donc tout l'approche est la même, elle part du fait que ce sont les individus qui tissent les relations sociales et que les individus ont une marge de manoeuvre, une marge de liberté en utilisant aussi bien le langage corporel mais aussi le langage verbal. Et ça c'est quelque chose de spécifique, de symbolique, ils pensent que la communication ne passe pas uniquement par les mots mais aussi par tous les médiateurs, comme le disent actuellement les spécialistes en communication, une bonne partie de notre communication passe par le langage non-verbal.

Et bien les interactionnistes s'intéressent aussi à cet aspect là, et pour eux les gens essaient toujours de donner un sens à leur utilisation, ce sens ne veut pas dire qu'il est vrai ou qu'il est faux, ce qui est intéressant pour l'individu c'est de donner un sens, de le comprendre. Et cette multitude de sens qui fait l'objet de la recherche des spécialistes et des chercheurs dans l'interactionnisme symbolique. Et donc pour eux il n'y a pas lieu de dire ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, il n'y a pas une recherche d'une vérité, la vérité n'existe que par rapport à ceux qui donnent un sens à cette vérité.

Donc elle est très relative, et le sens qu'on donne à la maladie, qu'on donne aux soins, qu'on

donne à la relation qu'on a avec les autres, dépend de plusieurs facteurs, des valeurs, des croyances, du patrimoine culturel, etc. qui définissent l'identité sociale et partant aussi de l'identité de l'individu. Donc pour les chercheurs qui opèrent dans ce cadre, eux croient qu'il est de la responsabilité des chercheurs de ne pas préjuger de structures qui surdéterminent les choix de l'individu, mais de partir justement de l'analyse du terrain, de l'analyse d'observer in situ comment les gens se comportent, comment ils adoptent des attitudes, comment ils se représentent de la maladie, comment ils en parlent.

Donc c'est un parti pris méthodologique aussi, qui va générer beaucoup de recherches, on va voir, qui va se chevaucher aussi avec le domaine, avec la psychologie sociale. Alors l'interaction symbolique, contrairement au fonctionnalisme, est basée sur des hypothèses. La première c'est qu'il y a une différence fondamentale entre le sujet de la sociologie et celui des sciences naturelles.

Pour les tenants de ce courant, l'étude des premiers porte des objets qui sont différents des sciences naturelles. La sociologie étudie les personnes dont les actions sont motivées. Donc ça c'est extrêmement important, puisque à la différence des sciences naturelles, il y a toujours une raison à tout acte, une raison à toute modification.

On peut trouver justement l'explication dans le sens qui est donné à ces actions. A la différence des objets physiques, qui sont des objets inanimés, et qu'on peut étudier de façon universelle, sans qu'il y ait vraiment de débat sur la nature de cet objet là. Ce qui n'est pas le cas pour l'élément humain, l'élément social, dont rien que la définition du contenu, qu'est-ce que l'humain, quels sont ses actions, quels sont ses comportements, quelles sont ses attitudes, quelle est la façon dont il a pris de telle ou telle décision, à partir de quel élément il a pioché.

J'ai seulement ces arguments, ou des informations, donc tous ces éléments-là ne peuvent pas obtenir des réponses universelles, mais peuvent demander à ce qu'on regarde de près, dans chaque contexte, et étudier de près, pour justement répondre à des questions. Selon des situations spécifiques. Pourquoi ? Parce que chaque culture a ses éléments qui lui sont propres.

Chaque représentation de la maladie collective, dans une société donnée, diffère d'une autre société. Et du coup, les interactions des individus vont être en quelque sorte aussi très, extrêmement riches, extrêmement complexes, parce qu'elles ne vont pas avoir le même référentiel. Et ça, c'est valable aussi bien pour les patients que pour les médecins.

Et on y reviendra. Il y a des études, par exemple, sur les représentations de la maladie, sur les représentations culturelles, quand les médecins, en Europe, qui est complètement différente de celle des médecins en Afrique, qui est complètement différente de celle des médecins en Asie. Et quand on dit en Asie, en Afrique, déjà, on parle de grands ensembles.

Et au sein de ces ensembles, l'attitude du médecin dans un pays donné est différente de l'attitude d'un autre pays, d'une autre société. Pour la simple raison que les deux, en dépit de leur

formation technique qui les prémunit et qui les dotent, prémunit contre des erreurs de pensée, des erreurs aussi pratiques, mais tous les deux sont confrontés à des situations culturelles différentes. Et parfois eux-mêmes sont le produit de ces cultures, parce qu'ils sont immergés dans leurs cultures, parce que dans leurs pratiques, ils sont aussi amenés à tenir compte de ces éléments culturels.

Et ça, c'est quelque chose qui va amener à des études qui sont approfondies pour comparer comment on voit la maladie entre le médecin d'une ère géographique culturelle par rapport à une autre géographique culturelle. Il y a des différences extraordinaires qui ressortent des recherches. De la même manière, la perception de la maladie est différente aussi entre les sociétés qui sont imprégnées d'hindouisme et entre celles qui sont imprégnées d'autres grands systèmes de pensée ou religieux, par exemple dans le monde musulman ou dans le monde chrétien.

Où alors dans d'autres sociétés, par exemple des sociétés qui sont imprégnées par des valeurs, on prend l'exemple du Japon du Shintoïsme. Donc si on prend rien que ces grands systèmes culturels qui peuvent donner des significations différentes, les individus au sein du système sont libres aussi de se faire une idée, de faire des choix, etc. à partir de ces valeurs, de ces systèmes de pensée de façon générale et ils donnent aussi des sens, et ça c'est aussi ce que les approches en interactionnisme symbolique montrent de plus en plus.

Comme on est dans une ère de métissage culturel, de mondialisation, les individus sont aussi de plus en plus libres de se faire une idée, de fabriquer une attitude à partir d'informations qu'ils vont chercher sur les réseaux sociaux, à partir d'autres supports. Donc voilà pour cette première idée, la deuxième idée c'est que l'interactionnisme symbolique explique les phénomènes de point de vue des gens, des individus, des participants si vous voulez. Et donc ça c'est très important, c'est qu'on inverse la posture, ce n'est pas le sociologue qui va donner des sens, qui va essayer d'interpréter à la place des gens, mais il va partir de ce que les gens pensent de tel ou tel phénomène.

Donc c'est donner la parole, c'est essayer de comprendre, en écoutant les interviewés, en regardant un petit peu comment eux les justifient, comment ils donnent de sens à leur maladie, à leur relation avec les médecins, leur relation avec la thérapie de façon générale, avec les médicaments, avec l'endorphinique, etc. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et on le verra si cette approche va influencer les courants récents dits de médecine centrée sur le patient.

On le verra quand on va traiter un petit peu de cet élément là. La troisième idée qu'on peut aussi retenir de l'interaction symbolique, c'est que le sens de l'action ne peut être compris, comme on l'a dit, qu'en étudiant des significations que les gens attachent à leur comportement. C'est pratiquement l'hypothèse de travail.

On ne va pas émettre des hypothèses à l'avance, mais on va partir de ce que les gens élaborent

comme signification de leur comportement et essayer de comprendre un petit peu ces significations. Quatrième idée sur laquelle se base l'interaction symbolique, c'est qu'ils s'intéressent surtout à la façon, et ça c'est ce qu'on appelle les points de vue, à la façon dont ils voient et comprennent le monde social. Donc voilà, ce qui intéresse surtout cette approche, c'est de comprendre ce point de vue, de comprendre cet angle de vue que les gens adoptent pour essayer de comprendre le monde social.

Et cinquième et dernier élément qu'on peut retenir par rapport à l'interaction symbolique, c'est que cette approche concerne moins le système ou la structure sociale de façon plus large que l'interprétation du comportement humain. Donc ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas les grandes institutions comme ça a été le cas pour l'approche fonctionniste qui a focalisé sur le système social, sur le rôle du malade, le rôle du médecin, etc. Dans le cadre d'institutions hospitalières, dans le cadre du bon fonctionnement de la société, ou dans le cadre de la théorie collective qui s'est intéressée aux grandes classes et aux conflits entre classes.

Non, ici l'interaction symbolique va essayer de s'intéresser surtout à l'interprétation du comportement humain. Donc c'est ça qui le différencie des deux autres courants. Alors l'importance de cette approche par rapport à la compréhension du comportement de la santé, c'est que cette approche vise essentiellement à examiner l'interaction de façon globale entre les différents acteurs dans le domaine de la santé et de la maladie.

Et l'accent va être mis sur la façon dont la maladie est l'expérience liée à l'individu, ce qu'on appelle l'expérience subjective de la maladie. C'est pour dire que la signification de la maladie va être présentée différemment d'un malade à un autre ou d'un groupe de malades à un autre. Ce qui va se faire selon l'échange entre le médecin et le patient, mais aussi entre le patient et d'autres patients, entre le patient et son lieu.

Alors l'argument ici qu'il faut retenir par rapport à l'interaction symbolique, c'est que la maladie est un accomplissement social plutôt qu'une simple question de dysfonctionnement physiologique. Et ça c'est un élément important. Quand on parle d'un accomplissement social parmi les différents acteurs, ça veut dire que tous les acteurs construisent le sens qu'ils vont donner à la maladie, qu'ils vont donner aussi aux soins, qu'ils vont donner à ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, etc.

Il n'y a pas quelque chose de donné a priori, mais ce sont des constructions qui relèvent justement du degré et de la nature d'interaction entre les différents acteurs. Alors le concept de l'étiquetage et de stigmatisation découle bien entendu de la perspective sociologique interactionniste et met l'accent sur l'importance des significations symboliques de la santé et de la maladie. En gros ces connotations sociales et les images de ce qui est normal, de ce qui est pathologique, de ce qui est déviant vont être des constructions sociales et vont être largement partagées pour être acceptées socialement.

Et qui vont définir justement ceux qui sortent de la règle, ceux qui sont hors de la norme, ceux qui sont en quelque sorte déviants par rapport à une situation jugée normale. Alors la théorie de l'étiquetage découle de travaux d'un sociologue qui a été en quelque sorte celui qui va en fonder les bases et qui a travaillé sur la déviance de façon générale. Et qui soutient que les groupes sociaux créent la déviance en établissant les règles et c'est l'infraction, c'est le fait d'emprunter ces règles qui constitue la déviance.

Donc en fait en focalisant son attention moins sur l'acte lui-même de déviance que sur la façon dont les gens jugent tel acte comme étant déviant ou ne l'est pas, L'auteur en question, Howard Baker, va bouleverser en quelque sorte l'approche de la déviance comme un état de fait, comme quelque chose qui est donné. Mais va complètement changer justement la perspective et va influencer toutes les études sur la question de la déviance, surtout dans le domaine qui nous intéresse, celui de la santé, mais avoir des implications dans d'autres domaines tels que le domaine de la criminologie. Alors l'auteur poursuit dans ses travaux l'idée qu'il va essayer de montrer que le déviant est celui auquel le label a été appliqué avec succès.

Le déviant n'est pas défini par l'acte qu'il a commis mais par le jugement et l'étiquetage que la société a produit à son égard. Donc la théorie de l'étiquetage, pour résumer, se concentre moins sur l'acte déviant lui-même que sur la réaction de la société à ce comportement particulier. Et donc c'est cette réaction de la société au comportement particulier qui va être au coeur de cette théorie de l'étiquetage.

Et on va voir comment, dans le domaine de la santé, et surtout quand on s'arrêtera sur comment a été traitée la notion de la maladie mentale, comment cette théorie va être utilisée pour constituer une référence pour expliquer les attitudes par rapport à la maladie. Alors certains auteurs font la distinction entre une déviance primaire et une déviance secondaire. Pour eux la déviance primaire est considérée comme celle qui consiste en acte déviant avant d'être étiquetée publiquement.

Et en principe cette déviance primaire a des implications, mais ce sont des implications, on va dire, de quelque sorte marginales. Des implications marginales pour le statut ou pour la structure psychique de la personne. Quand un individu se reconnaît malade, au départ, c'est un premier positionnement, une première attitude par rapport à la situation normale, par rapport à la référence de ce qui est normal, de ce qui ne l'est pas.

Mais, c'est là où c'est intéressant, nous disent les auteurs, la déviance secondaire est beaucoup plus importante, car elle vient du regard de l'autre, elle vient du jugement. Ce jugement peut être celui du médecin, celui du groupe, de la personne en face, du milieu auquel on appartient. Et cette déviance secondaire va altérer l'estime de soi, va altérer aussi les rôles sociaux d'une personne.

Cela fait suite à l'identification publique d'une personne comme étant déviante. La personne, en

réponse à cette réaction sociétale négative, si vous voulez, à ce jugement de normalité sociale, de ce qui est normal, de ce qui ne l'est pas, la personne va adopter un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de comportements qui vont se concrétiser dans une réponse directe à cet étiquetage, et qui vont modifier son comportement. Et il va agir en tant que tel, il va agir en tant que personne, disons, qui sort de la norme.

C'est ce que certains auteurs appellent une prophétie autoréalisatrice. En désignant une personne comme malade, en la désignant comme anormale, cette personne finit par couler dans le moule qu'on lui a préparé. Elle va justement s'auto-stigmatiser elle-même, elle va jouer ce rôle de malade, et ça, ça joue sur la psychologie de la personne, et va faire en sorte que la personne va sentir justement cet étiquetage extérieur, comme on dit, cette déviance secondaire.

Et ce processus, justement, est constitué, en quelque sorte, entre autres, par le diagnostic dans lequel les médecins s'engagent, dans un processus de classification par lequel les gens vont être étiquetés comme malades, et donc comme déviants. D'où l'importance du diagnostic, d'où l'importance de ce jugement qui va être, comme on dit, pris au sérieux, pris à bras de corps, par la personne qui a été étiquetée, et ces étiquettes de maladie véhiculent, bien sûr, des stéréotypes publics, qui sont si largement partagés que les caractéristiques de changement de comportement, de la déviance secondaire, vont être visibles, vont impacter le comportement de la personne qui a été ainsi désignée comme malade. Donc, les auteurs de la théorie de l'étiquetage nous disent que c'est un moyen de créer des maladies qui doivent être distinguées de la cause réelle des maladies.

Donc voilà, c'est une distinction entre comment on désigne quelqu'un qui est malade, ce n'est pas forcément lié, justement, aux causes réelles des maladies. C'est en cela que la maladie, en fait, relève plus d'une construction sociale, d'une désignation, et que la théorie de l'étiquetage nous aide à en comprendre les ressorts. C'est le cas pour la maladie mentale, qui est désignée comme telle, sans qu'il y ait une référence universelle.

Il y a un certain nombre de catégories qui servent de référence, mais de société à une autre, où définir ce qui est normal, ce qui ne l'est pas, dans le cadre de la santé mentale, va être remise en cause, déjà dans les années 60, notamment par un certain nombre de médecins, dont Elliot Fredson et d'autres auteurs, qui vont remettre en cause ce qu'on appelle les états psychotiques, et la définition de ces états-là, contrairement aux maladies purement biologiques, sur lesquelles on peut avoir un minimum de consensus. Donc la théorie de l'étiquetage va bouleverser complètement la vision qu'on peut avoir de la maladie. Les limites de l'interactionisme symbolique, qui ont été signalées par ces critiques et par ces détracteurs, focalisent d'abord sur son parti pris, son choix micro, et qui conduit parfois à ignorer l'influence au niveau macro-sociologique des grandes structures plus vastes, en focalisant l'importance sur cet aspect-là.

Du coup, toute l'explication, tous les phénomènes qui peuvent être expliqués, non pas au niveau individuel, au niveau micro, mais au niveau macro, sont écartés, parfois sont minorés. La

deuxième critique, c'est la tendance à remettre de façon générale les facteurs externes, et leur impact sur les choix de l'individu. En l'occurrence, le fait de négliger l'impact de la classe, l'impact de la culture, l'impact aussi des éléments qui sont extérieurs à l'individu.